

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Fistula-in-Ano

معلومات الإقرار – نسخة المريض الناصور الشرجي

1. What is a fistula-in-ano?

A fistula in ano is a hollow track lined with granulation tissue connecting a primary opening inside the anal canal to a secondary opening in the perianal skin.

Surgical removal of the abnormal track between the anus and skin is needed.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **Anaesthetic: Nerve Block OR Epidural and Spinal Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Asprin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound

1. ما هو الناصور الشرجي ؟

الناصور الشرجي هو ممر مجوف ، ومبطن بنسيج محبب ، يصل بين فتحتين ، الأولى رئيسية في القناة الشرجية ، والثانية ثانوية على الجلد المحيط بالشرج .
هنا حاجة لاستئصال الممر غير الطبيعي بين الشرج والجلد .

2. التخدير الذي أتلقيه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .

اقرأ تعليمات التخدير الخاصة بك

أو معلومات التخدير لعصب معين

أو معلومات التخدير النصفى: التخدير النخاعي (الشوكي) & تخدير فوق الجافية ، لتحصل على المزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة . إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج .
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها .

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- حدوث نزيف مما قد يتطلب إعادةك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن)
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر .
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.

- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- There will be an open wound where the fistula was removed. This will take 2-3 weeks to heal.
- If the fistula involves an excessive amount of muscle around the anus, the doctor may insert a small plastic marker to assist in drainage until further surgery is possible.
- The condition may recur, and an abscess about the anal region may occur.
- Scarring may develop about the anus, and it may be painful or thickened.
- Rarely the muscles at the anus may be over stretched or over cut with a resultant weakness in the area. This could cause problems with control of the bowels (incontinence). A pad may need to be worn and/or further surgery may be needed.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

Notes to talk to my doctor about:

والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية

- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد انفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر خاصة بهذا الإجراء:

- سيكون هناك جرح مفتوح في الموضع الذي أزيل من الناسور. يستغرق ذلك 2-3 أسابيع ليلتئم.
- إذا احتوى الناسور على قدر كبير من العضلة حول الشرج ، قد يدخل الطبيب علامة بلاستيكية صغيرة للمساعدة في التصريف لحين إجراء جراحة أخرى.
- قد تعود الحالة للظهور ، وقد يتكوّن خراج بالقرب من منطقة الشرج.
- قد يحدث تندب بالقرب من الشرج وقد يكون مؤلماً أو سميماً.
- نادراً ما يحدث أن يتم مد عضلات الشرج أكثر من اللازم أو أن تقطع أكثر من اللازم مما يسبب ضعفاً في المنطقة. قد يؤدي ذلك إلى مشاكل في السيطرة على الأمعاء (سلس البراز) ، مما قد يستدعي الحاجة إلى ارتداء حفاظ أو إلى جراحة أخرى.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
